

TEMA 2.8 • TRAUMATOLOGÍA

Lesiones de Extremidades Inferiores

PERFIL EUNACOM 3.01.1.001
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Las lesiones de rodilla son un motivo de consulta extremadamente frecuente en la práctica clínica y en el examen EUNACOM. Aunque cada estructura tiene una presentación particular, comparten elementos comunes: todas cursan con **dolor de rodilla** e **impotencia funcional**.

Dado que los meniscos y ligamentos son tejido conectivo y fibrocartilago, no son visibles en la radiografía convencional. Por lo tanto, el estándar de oro para el diagnóstico de partes blandas es la **Resonancia Magnética Nuclear (RMN)**.

1. Lesiones Meniscales

Los meniscos (medial y lateral) actúan como amortiguadores y estabilizadores de la rodilla. Su lesión suele ocurrir por mecanismos de **torsión brusca** (giros con el pie fijo en el suelo).

Clínica Específica

- **Bloqueo articular:** Sensación de que la rodilla se queda "atascada" o trabada al caminar. - **Dolor en la interlínea articular:** Dolor a la palpación directa del espacio entre el fémur y la tibia. - **Sensación de inestabilidad.**

Maniobras Diagnósticas

La maniobra más característica es la **Prueba de Apley**: - Paciente en decúbito prono con la rodilla flectada en 90°. - Se ejerce presión hacia abajo (compresión) y se rota la pierna.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Regla del Talón en la Maniobra de Apley: El talón siempre apunta al menisco que se está evaluando (y que duele): - **Rotación Externa:** El talón apunta hacia adentro → Evalúa el **Menisco Interno (Medial)**. - **Rotación Interna:** El talón apunta hacia afuera → Evalúa el **Menisco Externo (Lateral)**.

Tratamiento

1. **Conservador:** Reposo, AINES y ejercicios de fortalecimiento de **cuádriceps**. 2. **Quirúrgico:** Indicado si falla el tratamiento conservador o si la lesión es muy extensa. Se realiza mediante **artroscopía** (menos morbilidad que la cirugía abierta).

2. Lesiones de Ligamentos Cruzados

Los ligamentos cruzados son los principales estabilizadores de la traslación anterior y posterior de la tibia. Su síntoma cardinal es la **inestabilidad** ("siento que la rodilla se me va").

Diferencias entre LCA y LCP

TABLA 2.8.1: CARACTERÍSTICA VS LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA)

CARACTERÍSTICA	LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA)	LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR (LCP)
Mecanismo	Hiperextensión o desaceleración brusca.	Hiperflexión o golpe directo anterior ("golpe en tablero").
Signo Clínico	Cajón Anterior (tibia se desplaza hacia adelante).	Cajón Posterior (tibia se desplaza hacia atrás).
Frecuencia	Mucho más frecuente.	Menos frecuente.
Tratamiento	Quirúrgico (habitual en jóvenes/activos).	Conservador (inicialmente). Quirúrgico en deportistas.

NOTA CLÍNICA

La rotura del LCA genera una gran inestabilidad funcional, por lo que en la mayoría de los pacientes jóvenes o deportistas la resolución es quirúrgica mediante reconstrucción artroscópica.

3. Lesiones de Ligamentos Colaterales

También conocidas comúnmente como **"Esguince de Rodilla"**. Se encargan de la estabilidad lateral (varo/valgo).

Clínica y Mecanismo

- **Ligamento Colateral Medial (Interno):** Se lesiona por un **estrés en Valgo** (la rodilla se va hacia adentro, abriendo la cara interna). Es el más frecuente y suele asociarse a lesiones del menisco interno. - **Ligamento Colateral Lateral (Externo):** Se lesiona por un **estrés en Varo** (la rodilla se va hacia afuera, como "vaquero"). Es menos frecuente y suele ser extracapsular.

Signo del Bostezo

Es la apertura anormal de la articulación al forzar el varo o valgo: - **Bostezo al Valgo:** Indica lesión del Colateral Medial. - **Bostezo al Varo:** Indica lesión del Colateral Lateral.

Manejo

El tratamiento suele ser **conservador**. Se utiliza un **inmovilizador de rodilla** (férula que permite la higiene pero evita movimientos laterales) y rehabilitación. Rara vez requieren cirugía.

4. Disfunción Patelofemoral (Síndrome de Hiperpresión Rotuliana)

Es una causa muy común de consulta, especialmente en personas jóvenes que realizan actividad física.

Clínica

- **Dolor anterior de rodilla:** Localizado "detrás" o alrededor de la rótula. - **Desencadenantes:** Subir o bajar escaleras, caminar por cerros (trekking) o estar sentado mucho tiempo. - Puede haber sensación de que la rótula "se corre".

EUNACOM CRITERIOS

El diagnóstico de la **Disfunción Patelofemoral** es eminentemente **CLÍNICO**. No requiere RMN de entrada a menos que se sospechen lesiones meniscales o ligamentarias asociadas.

Tratamiento

- Reposo relativo en fase aguda y AINES. - **Pilar Fundamental:** Fortalecimiento del **músculo cuádriceps** (especialmente el vasto medial) para centrar la rótula y mejorar la mecánica articular.

5. Diagnósticos Diferenciales (Dolor Periarticular)

Es fundamental distinguir las lesiones intraarticulares de las tendinitis o inflamaciones locales:

- **Tendinitis de la Pata de Ganso (Pes Anserinus):** Dolor en la cara anteromedial e inferior de la rodilla (inserción de los tendones sartorio, grácil y semitendinoso).
- **Enfermedad de Osgood-Schlatter:** Una entesitis (inflamación de la inserción) del tendón rotuliano en la tuberosidad anterior de la tibia. Típico en adolescentes deportistas.
- **Síndrome de la Banda Iliotibial (Fascia Lata):** Dolor en la cara lateral de la rodilla, común en corredores ("rodilla del corredor"). El dolor se localiza cerca de la cabeza del peroné.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Ante una rodilla con aumento de volumen agudo (hemartrosis) tras un traumatismo, siempre sospechar rotura del **LCA** o fractura osteocondral. Si el aumento de volumen es lento (horas después), orienta más a una lesión meniscal.

Resumen para el EUNACOM

- **Meniscos:** Bloqueo + Apley positivo + RMN.
- **LCA:** Inestabilidad + Cajón Anterior + Cirugía.
- **Colaterales:** Estrés varo/valgo + Bostezo + Manejo Conservador.
- **Patelofemoral:** Dolor al bajar escaleras + Fortalecimiento de cuádriceps.

Traumatología: Generalidades Fracturas de Miembro Inferior Artritis Séptica

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Un paciente se tuerce el tobillo y llega a urgencias con dolor, equimosis y dificultad para apoyar el pie. ¿Cuál es la conducta inicial?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Lesiones de Extremidades Inferiores. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Las fracturas de fémur, pierna y tobillo se tratan quirúrgicamente por regla general.
- La fractura de fémur requiere cirugía porque el cuádriceps tracciona los fragmentos y los cabalga.
- La fractura de pierna se complica con síndrome compartimental y trombosis venosa profunda.
- Los signos de fractura de tobillo son: imposibilidad de apoyar, crepitación ósea, y dolor a la compresión de maléolos, base del quinto metatarsiano o cabeza del peroné.
- Ante toda lesión de tobillo siempre se pide radiografía para descartar fractura antes de diagnosticar esguince.
- El esguince de tobillo se trata con RICE más bota removible; la bota es preferible al yeso.
- Si la radiografía de tobillo es normal el diagnóstico es esguince; si hay fractura el tratamiento es quirúrgico.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (LESIONES DE EXTREMIDADES INFERIORES)**PREGUNTA 1**

Un paciente se tuerce el tobillo y llega a urgencias con dolor, equimosis y dificultad para apoyar el pie. ¿Cuál es la conducta inicial?

- A)** Inmovilizar con yeso y dar de alta sin radiografía porque es clínica de esguince
- B)** Solicitar radiografía de tobillo para descartar fractura
- C)** Diagnóstico de esguince; RICE más bota removible sin radiografía
- D)** TAC de tobillo como primera imagen para ver los ligamentos
- E)** RMN de tobillo para evaluar los ligamentos laterales

PREGUNTA 2

Un paciente con fractura de tobillo confirmada en la radiografía. ¿Cuál es el tratamiento?

- A)** RICE más bota removible por cuatro semanas
- B)** Yeso de pierna por seis semanas
- C)** Cirugía con reducción y osteosíntesis
- D)** Observación ambulatoria y control en una semana
- E)** Inmovilización con bota de yeso y evaluar en dos semanas

PREGUNTA 3

Un paciente con fractura de pierna tiene dolor muy intenso en la pantorrilla a las cinco horas de la lesión que aumenta al mover los dedos del pie. ¿Cuál es la complicación más probable?

- A)** TVP; ecodoppler y anticoagulación
- B)** Síndrome compartimental; fasciotomía urgente
- C)** Embolia grasa; soporte
- D)** Osteomielitis; antibióticos
- E)** Distrofia simpático refleja; pregabalina

RESUMEN: LESIONES DE EXTREMIDADES INFERIORES

Las lesiones de extremidades inferiores más importantes son la fractura de fémur, la fractura de pierna y la fractura de tobillo. Su clínica es la general de las fracturas: dolor, impotencia funcional, desviación de ejes y crepitación ósea. El diagnóstico es con radiografías. A diferencia de las extremidades superiores, estas tres fracturas se tratan quirúrgicamente por regla general, salvo excepciones menores. La fractura de fémur se complica porque el cuádriceps es un músculo muy fuerte que tracciona los fragmentos y los cabalga, haciendo que no responda bien al manejo ortopédico. Requiere cirugía sí o sí. La fractura de pierna se complica clásicamente con síndrome compartimental y trombosis venosa profunda. El tratamiento quirúrgico permite además que el paciente apoye antes, evitando las complicaciones del reposo prolongado como la trombosis. Respecto al tobillo, hay que diferenciar el esguince de tobillo de la fractura de tobillo. Ambos se producen por mecanismo de inversión o eversión del pie. Los signos que orientan a fractura son: imposibilidad de apoyar, crepitación ósea, y dolor a la compresión de las prominencias óseas como los maléolos, la base del quinto metatarsiano o la cabeza del peroné. La conducta ante toda lesión de tobillo es pedir radiografía para descartar fractura: si hay fractura el tratamiento es quirúrgico; si la radiografía es normal el diagnóstico es esguince y el tratamiento es reposo, hielo, compresión y elevación más inmovilización con bota removible. La bota removible es preferible al yeso porque es más cómoda, permite bañarse y tiene menos efectos adversos.